リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年10月11日（日）

第31号 朝刊

きょうの紙面 ▸ 回復期・予測モデル ▸ 脳卒中・攻撃行動 ▸ 高齢・心理 ▸ 短信 8本

■ 回復期・予測モデル

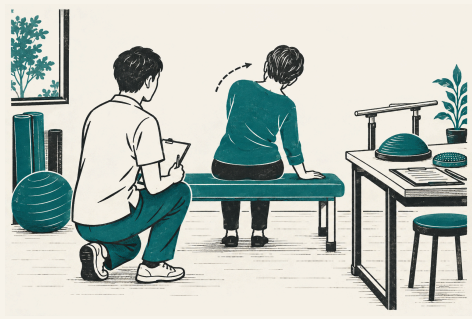
回復期の脳卒中、実績指数48以上を入棟時に予測　体幹評価で精度上昇

150人の単施設研究、BBS・TIS追加で補正後AUC 0.73→0.78

回復期リハ病棟の脳卒中患者150人で、個人レベルの実績指数相当値48以上を達成できるかを、入棟時の情報から予測する研究が理学療法学に早期公開されました（ツカザキ病院、単施設。10月10日公開）。基本モデルは年齢、発症後日数、入院前の modified Rankin Scale、入棟時のFIM認知項目合計の4つです。

ここに Berg Balance Scale（BBS）や Trunk Impairment Scale（TIS）を加えると、補正後AUCは基本モデルの0.733から、BBS追加で0.772、TIS追加で0.784、両方追加で0.781になりました。補正後 Brier score も 0.204 から、それぞれ 0.187、0.182、0.183へ下がっています。FIM運動項目の合計を含めた感度解析でも、追加モデルのほうが数値上は良好でした。

評価は記述的でモデル同士の優劣は検定しておらず、1施設・150人で外部検証もありません。著者も「追加的な予測情報となる可能性」にとどめています。入棟時にバランスと体幹機能をそろえて測っておくことが、見通しを話し合う材料になります。



入棟時のバランス・体幹評価は、見通しを話し合う材料のひとつ。

出典 理学療法学（早期公開）↗

数字で見る

150人
回復期脳卒中患者の対象

0.733→0.784
補正後AUC（基本→TIS追加）

0.204→0.182
補正後Brier score（同）

■ 脳卒中・攻撃行動

脳卒中の回復期入院、初回の攻撃行動は60日で15.6%　LOS約18日延長

単一の神経リハ専門病院で、2005〜2023年に発症3か月以内に入院した初発脳卒中1,683人を後ろ向きに調べました。初回の攻撃行動は1,000患者日あたり 2.83（95%CI 2.53〜3.16）で、30日以内の累積リスクは8.1%、60日で15.6%でした。

攻撃行動があった群は、尿路感染が1.92倍（1.43〜2.57）、転倒が1.28倍（1.00〜1.63）。在院日数は中央値で+17.9日、傾向スコアで1対1に合わせた317組でも+9.8日（+4.1〜+15.2）でした。単施設・カルテ記載からの観察で、因果は言えません。入院後約2か月を見守りの窓とし、感染と転倒の確認、退院見通しの更新を合わせて考える材料になります。



出典 PM&R↗

■ 高齢・心理

「老いは喪失」と捉える高齢患者はリハ効率が低い　158人

大腿骨骨折または脳卒中で入院した高齢の回復期患者158人（平均77.2歳）に、入院時に老いへの一般的な見方（AAQ）と自分自身の変化への気づき（AARC）を答えてもらいました。退院までの機能的自立度の改善を、潜在的な改善幅に対する割合としたリハ効率（RE）で比べています。

経路解析では、「老いは喪失」と捉える項目（AAQ-Losses と AARC-Losses）がREの低さと関連し、成長・得るものと捉える項目は有意な関連がありませんでした。単一の観察研究で、気持ちが結果を決めるとは言えません。入院時に本人の見方を聞き取り、目標を作り直す手がかりになります。



出典 J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci↗

短信

〈脳卒中〉VR上肢リハ、エチオピアの20人で実施可能
亜急性〜慢性の20人、9回の介入で出席率93%。ARAT 33.0→48.6の対照なし予備研究。 出典 PLoS One↗

〈嚥下〉脳卒中後の嚥下・口腔状態と便中菌を横断解析
65歳以上の入院156人。FILS 7未満は便中の口腔関連菌スコアが低い。因果は不明。 出典 Clin Nutr ESPEN↗

〈心臓リハ〉CABG後の在宅型と通所型、VO2に差なし
9RCT・991人。peak VO2のMD −0.22。心理面はI^2が90%超で結論が出せない。 出典 Heart Lung↗

〈体幹〉TIS、亜急性脳卒中で妥当性を確認
他尺度とr=0.58〜0.76の相関。退院時の歩行自立の識別は中等度（早期公開）。 出典 理学療法学↗

〈THA〉THA後の退院時期、術後1週のMFESだけが関連
84関節の単施設。術前指標では予測しにくく、術後1週のMFESだけが関連した。 出典 理学療法学↗

〈嚥下〉頸髄症の前方手術後、嚥下障害は1年で36%に残存
CSM-Protect二次解析132人。1年で36.4%に残存。C5レベルと術前の嚥下障害が要因。 出典 J Neurosurg Spine↗

〈ICU〉緊急腹部手術後の統合訓練、離脱成功率95.6%
ICU 2施設のRCT・90人。成功率は95.6%対82.2%。MIPの群間差はなし。 出典 Arch Phys Med Rehabil↗

〈心臓リハ〉ハイブリッド心臓リハ、2016年から増えず
6,905プログラム中1,505が回答。提供は31.1%で、償還の乏しさが壁になっている。 出典 PLoS One↗